EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 79663
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-27 11:18:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DE LAS ROS CONCHA VASQUEZ			RUN	: 8.066.240-8
F.Nac	: 20-01-1959	Edad	: 65 AÑOS, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	: LA NUEVA VIDA PASAJE LA LUNA 676			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 992639690		
Fecha Ingreso	: 2024-02-24	Fecha Egreso	: 2024-02-27 11:18:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Progresión ACV talamocapsular derecho ATE
- DM2 mal controlada HbA1C 12
- HTA
- Trastorno neurocognitivo probable origen vascular
- Obesidad
- Déficit de Vit D

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- DM2 mal controlada HbA1C 12
- HTA
- Trastorno neurocognitivo probable origen vascular
- Obesidad
- Déficit de Vit D

Paciente con antecedentes previamente mencionados, con hospitalización reciente entre el 08-12 feb 2024 en relaciónn a ACV talamico anterior derecho con el siguiente estudio de relevancia:
- ColT 296, HDL 38, LDL 176, TGL 411. TSH 2.65, T4L 0.76. VitB12 486. HbA1c 12.0.
- AngioTC de cerebro y cuello Ateromatosis intracraneana difusa, sin estenosis significativas.

Se mantiene con siguiente esquema posterior a alta.
- Atorvastatina 40 mg 2 comprimido al día.
- Aspirina 100 mg 1 comprimido al día.
- Famotidina 40 mg 1 comprimido al día.
- Carvedilol 6,25 mg 0.5 comprimido cada 12 hrs
- Losartan 50 mg 1 comprimido al día.
- Pregabalina 75 mg 1 comprimido al día.
- Clopidogrel 75 mg 1 comprimido al día.
- Donepecilo 10 mg 0.5 comprimido al día.
- Insulina NPH 28und am y 18 unds pm Insulina Cristalina 10 unds precomidas
- Colecalciferol 50.000 und semanal por 6 semanas
- Haloperidol 1 mg, 1/2 - 1

Consultan el 23/02/24 en servicio de urgencias por profundización del déficit de hemicuerpo izquierdo. Al ingreso de SU de HSC con FC 75 lpm, PA 168/78 mmHg, T° 36°C, HGT 286 mg/dL. Se realizó control de TC de encéfalo sin contraste en que se constata mayor reclutamiento isquémico talamocapsular derecho. Se hospitaliza para evaluación por neurología.
Considerando hallazgos en TC de encéfalo sin contraste y angioTC reciente, se decide no realizar nuevo estudio de vasos.
Se cambia esquema de doble antiagregación y se mantiene en observación para evaluar progresión del déficit. Con el paso de los días regresa paresia en forma parcial. Estudio de cardioembolías se decide realizar en forma ambulatoria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido segun tolerancia.
2. Régimen papilla hiposódico diabético fraccionado asistido.
3. Atorvastatina 40 mg 2 comprimido al día, vía oral.
4. Aspirina 100 mg 1 comprimido al día, vía oral.
5. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al día, vía oral.
6. Carvedilol 6,25 mg 0.5 comprimido cada 12 hrs
7. Losartan 50 mg 1 comprimido al día, vía oral.
8. Pregabalina 75 mg 1 comprimido al día, vía oral.
9. Cilostazol 100 mg cada 12 horas, vía oral.
10. Donepecilo 10 mg 0.5 comprimido al día, vía oral.
11. Insulina NPH 30 UAM y 20 UPM Insulina Cristalina 10 unds precomidas
12. Colecalciferol 50.000 und semanal por 6 semanas
13. Haloperidol 1 mg, 1/2 - 1
14. Kinesioterapia motora
15. Seguimiento fonoaudiología
16. Control GES ACV neurología en HSC
17. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 26/02/24 ColT 158, HDL 36, LDL 81, TGL 204,
- 25/02/24 Creat 0.7, MDRD 83, Uremia 30, ELP 137/4.6/99, Hb 16, Hto 47.3, Leuco 13000, plaq 252.000, VHS 16, PCR 15.5
- 23/02/24 TC de encéfalo sin contraste: progresión de extensión infarto subagudo talamocapsular izquierdo.
- 23/02/24 Glic 291, Creat 0.8, MDRD 71.99, ELP 142/4.7/105, Hb 14.6, Hto 43.7, Leuco 8500, plaq 258.000. PCR 16.0. INR 1.0. TTPa 24. Tropo 5.2. HbA1c 11.8

OBSERVACIONES:

Examen neurológico al alta:
SV FC 86 lpm, T° 36.2°C, PA 148/88 mmHg, Sat 93%, HGT 275 mg/dL
- Vigil, parcialmente orientada en espacio, desorientada en tiempo inatenta. Sin alteración de lenguaje. Disartria leve
- Pupilas isocóricas, RFM +/+, CV normal. ptosis derecha antigua. OCM normal. Sensibilidad facial simétrica. Protruye lengua en linea media.
- Hemiparesia izquierda braquiocrural M3, plantar extensor izquierdo.
- Hemohipoestesia BC izquierda
- Coordinacion sin alteraciones en hemicuerpo derecho
- Signos meningeos negativo

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO